	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI **Secretaria Municipal de Saúde** **Departamento de Nutrição**

Tipo de Doc: Protocolo para concessão de fórmulas e suplementos alimentares	**Emitido por:** Departamento de Nutrição
Data: 01/01/2025	**Revisado por:** Atenção Primária à Saúde
Revisão: Emissão inicial	**Aprovado por:** Thereza Christina Griep

PROTOCOLO PARA CONCESSÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES

ARAGUARI

2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Nutrição

PROTOCOLO PARA CONCESSÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Protocolo elaborado pelos nutricionistas do Departamento de Nutrição, da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Araguari, visando elencar as fórmulas e suplementos alimentares disponibilizados pelo município, bem como estabelecer os critérios para concessão.

ARAGUARI

2025

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AGS	Avaliação Subjetiva Global do Estado Nutricional
APLV	Alergia à proteína do leite de vaca
CID	Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
CNS	Cartão Nacional de Saúde
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
DPOC	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
DRI	*Dietary reference intakes*
GTT	Gastrostomia
HIV	Vírus da imunodeficiência humana
HTLV1	Vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1
HTLV2	Vírus linfotrópico de células T humanas tipo 2
IMC	Índice de Massa Corporal
MG	Minas Gerais
MNA	Miniavaliação Nutricional
OMS	Organização Mundial da Saúde
PNSAN	Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
RG	Registro Geral
SISAN	Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
SNE	Sonda nasoenteral
SNG	Sonda nasogástrica
SUS	Sistema Único de Saúde

SUMÁRIO

1. FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DISPONIBILIZADOS 6
1.1 Fórmulas e suplementos alimentares para crianças 6
1.2 Fórmulas e suplementos alimentares para adolescentes, adultos e idosos 7
2. GRUPOS POPULACIONAIS A SEREM BENEFICIADOS 7
3. OBJETIVOS DA CONCESSÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES 7
4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 8
4.1 Fórmulas de partida (0 a 05 meses e 29 dias) 8
4.2 Fórmulas de seguimento (06 a 08 meses e 29 dias) 8
4.3 Fórmulas de seguimento (09 meses a 11 meses e 29 dias) 8
4.4 Fórmula infantil à base de leite de vaca, isenta de lactose e glúten (0 a 01 ano, 11 meses e 29 dias) 9
4.5 Fórmula infantil de origem vegetal à base de proteína isolada de soja (06 meses a 01 ano, 11 meses e 29 dias) 9
4.6 Fórmula infantil com proteína extensamente hidrolisada ou com aminoácidos livres (0 a 01 ano, 11 meses e 29 dias) 9
4.7 Fórmula alimentar infantil nutricionalmente completa para crianças de 01 a 10 anos 10
4.8 Fórmula alimentar e suplemento alimentar para adolescentes, adultos e idosos 10
5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 11
5.1 Avaliação nutricional de crianças e adolescentes (0 a 19 anos e 29 dias) 11
5.2 Avaliação nutricional de adultos (20 anos a 59 anos e 29 dias) 12
5.3 Avaliação nutricional de idosos (60 anos ou mais) 13
6. PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES 14
7. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA QUANTIDADE DE FÓRMULA A SER FORNECIDA 15
7.1 Menores de 06 meses 16
7.2 De 06 meses a 08 meses e 29 dias 16
7.3 Crianças com 09 meses ou mais 16
7.4 Crianças maiores de 02 anos, adolescentes, adultos e idosos 16

8 RELATÓRIO DO SERVIÇO SOCIAL 17
REFERÊNCIAS 18
APÊNDICES 21
APÊNDICE 1 – RELATÓRIO MÉDICO 21
APÊNDICE 2 - RELATÓRIO DO SERVIÇO SOCIAL - FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES 22
APÊNDICE 3 - ESCALA DE RISCO FAMILIAR 24
ANEXOS 26
ANEXO 1 - TRIAGEM DE RISCO NUTRICIONAL EM PEDIATRIA (STRONGKIDS) 26
ANEXO 3 - MINIAVALIAÇÃO NUTRICIONAL - VERSÃO REDUZIDA (MNA®) 28

PROTOCOLO PARA CONCESSÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOSS ALIMENTARES

Considerando a Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 2.715 de 17 de novembro de 2011, que atualiza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição;

Considerando a Lei nº 11.346 de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN);

Considerando o Decreto nº 7.272 de 25 de agosto de 2010, que regulamenta a Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o SISAN com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada, institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e dá outras providências;

Considerando a Resolução nº 39 de 09 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde;

Considerando a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.246 de 08 de janeiro de 1988, que dispõe sobre o Código de Ética Médica;

Considerando a Resolução do Conselho Federal de Serviço Social nº 273 de março de 1993, que institui o Código de Ética do Profissional Assistente Social e dá outras providências;

Considerando a Resolução do Conselho Federal de Nutrição nº 334 de 10 de maio de 2004, que dispõe sobre o Código de Ética dos Nutricionistas;

Considerando a Política de Saúde implementada no Município de Araguari/Minas Gerais;

Considerando a necessidade de disciplinar a concessão de fórmulas e suplementos alimentares inclusos nos protocolos clínicos do Ministério da Saúde no âmbito do Município de Araguari;

Sugere-se que:

1º Seja instituído o elenco de fórmulas e suplementos alimentares a serem utilizados para recuperação da saúde e tratamento de agravos, conforme descritos no item 1.

2º Que sejam aprovados os critérios para concessão de fórmulas e suplementos alimentares visando recuperação da saúde e tratamento de agravos na esfera ambulatorial e/ou domiciliar de doenças que exigem terapêutica especial no âmbito da saúde pública municipal (item 4).

1. FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DISPONIBILIZADOS

1.1 Fórmulas e suplementos alimentares para crianças

- Fórmula infantil de partida com ferro para lactentes de 0 a 06 meses de idade;
- Fórmula infantil de seguimento com ferro para lactentes de 06 meses a 01 ano de idade;
- Fórmula infantil especial, isenta de lactose e glúten, à base de leite de vaca, óleos vegetais e maltodextrina;
- Fórmula infantil de origem vegetal à base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e glúten;
- Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância com proteína extensamente hidrolisada e restrição de lactose;
- Fórmula infantil à base de aminoácidos livres não alergênicos, nutricionalmente completa, para crianças menores de 03 anos de idade;
- Fórmula infantil à base de aminoácidos livres não alergênicos, para crianças de 01 a 10 anos de idade;

- Alimento nutricionalmente completo para nutrição oral ou enteral para crianças de 01 a 10 anos;
- Módulos de oligossacarídeos, proteína e triglicerídeos de cadeia média.

1.2 Fórmulas e suplementos alimentares para adolescentes, adultos e idosos

- Alimento nutricionalmente completo para nutrição oral ou enteral;
- Suplemento alimentar para nutrição oral ou enteral;
- Módulos de oligossacarídeos, proteína e triglicerídeos de cadeia média.

2. GRUPOS POPULACIONAIS A SEREM BENEFICIADOS

2.1 Crianças menores de 06 meses residentes em Araguari, em situações que contraindiquem o aleitamento materno, relacionadas à saúde da criança ou da mãe;

2.2 Crianças maiores de 06 meses residentes em Araguari que possuam comprometimento nutricional ou em risco nutricional associado com alguma doença catabólica;

2.3 Adolescentes, adultos e idosos residentes em Araguari em risco nutricional associado com doença catabólica, desnutrição leve/moderada associada com doença catabólica ou indivíduos com desnutrição grave.

3. OBJETIVOS DA CONCESSÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES

O fornecimento de fórmulas e suplementos alimentares realizado pelo Departamento de Nutrição da Prefeitura Municipal de Araguari tem como principal objetivo promover a recuperação nutricional e de saúde dos pacientes que apresentam alguma doença catabólica, e não se trata de uma ação de caráter social. Esses produtos são disponibilizados para atender a necessidades específicas de indivíduos com condições médicas que requerem suporte nutricional especializado. A distribuição é direcionada a pacientes que precisam, visando complementar ou substituir sua

alimentação regular a melhoria do estado nutricional e a recuperação da saúde, de acordo com prescrições e orientações profissionais.

4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

4.1 Fórmulas de partida (0 a 05 meses e 29 dias)

- Restrições/limitações ao aleitamento materno relacionadas à criança: galactosemia, fenilcetonúria, síndrome de xarope de bordo, fissuras labiopalatais, prematuridade com sequelas neurológicas/motoras e/ou comprometimento nutricional, gemelaridade com sequelas neurológicas/motoras e/ou comprometimento nutricional, doenças congênitas graves com comprometimento nutricional, crianças em dieta enteral;
- Restrições ao aleitamento materno relacionadas à mãe: mães infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), mães infectadas pelo vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV1 e HTLV2), uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação, insuficiência cardíaca, doenças graves de fígado, rins, pulmões, câncer, psicose pós-natal grave, doenças psiquiátricas que colocam em risco a vida da criança, tuberculose ativa, varicela ativa, herpes simples com lesão na mama, sífilis com lesão na mama, doença de Chagas aguda com fissura no mamilo e sangramento;
- Crianças com qualquer grau de comprometimento nutricional (peso/idade e altura/idade inferiores ao percentil 15).

4.2 Fórmulas de seguimento (06 a 08 meses e 29 dias)

- Crianças atendidas previamente pelo Departamento de Nutrição, que tenham sido enquadradas nos critérios descritos no item 4.1 e que recuperaram o estado nutricional. Para estas, será concedido o uso da fórmula de seguimento durante 03 meses (06 a 08 meses e 29 dias), para que ocorra a adaptação da criança à alimentação complementar e uso do leite de vaca;
- Crianças com qualquer grau de comprometimento nutricional (peso/idade e altura/idade inferiores ao percentil 15).

4.3 Fórmulas de seguimento (09 meses a 11 meses e 29 dias)

- Crianças atendidas previamente pelo Departamento de Nutrição, que tenham sido enquadradas nos critérios descritos no item 4.1 e que não recuperaram o estado nutricional. Para estas, será mantido o uso da fórmula de seguimento;
- Crianças com qualquer grau de comprometimento nutricional (peso/idade e altura/idade inferiores ao percentil 15).

4.4 Fórmula infantil à base de leite de vaca, isenta de lactose e glúten (0 a 01 ano, 11 meses e 29 dias)

- Indicada para crianças que apresentam intolerância à lactose ou doença celíaca.
Observação: A fórmula infantil à base de leite de vaca, isenta de lactose e glúten será disponibilizada para crianças com 02 anos ou mais que apresentam síndrome de má-absorção e comprometimento intestinal, devidamente comprovados por meio de testes diagnósticos indicados pelo gastropediatra.

4.5 Fórmula infantil de origem vegetal à base de proteína isolada de soja (06 meses a 01 ano, 11 meses e 29 dias)

- Para crianças maiores de 06 meses com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) ou intolerância à lactose, que tenham mantido aleitamento materno e realizado dieta de exclusão materna de leite de vaca e derivados sem resposta adequada;
Observação: A fórmula infantil de origem vegetal à base de proteína isolada de soja será disponibilizada para crianças com 02 anos ou mais apresentam síndrome de má-absorção e comprometimento intestinal, devidamente comprovados por meio de testes diagnósticos indicados pelo gastropediatra.

4.6 Fórmula infantil com proteína extensamente hidrolisada ou com aminoácidos livres (0 a 01 ano, 11 meses e 29 dias)

- Crianças menores de 02 anos com síndrome de má-absorção e com comprometimento intestinal em investigação.
Observação: A fórmula infantil com proteína extensamente hidrolisada ou com aminoácidos livres será disponibilizada para crianças a partir de 02 anos ou mais que

apresentam síndrome de má-absorção e comprometimento intestinal, devidamente comprovados por meio de testes diagnósticos indicados pelo gastropediatra.

4.7 Fórmula alimentar infantil nutricionalmente completa para crianças de 01 a 10 anos

- Crianças maiores de 01 ano com comprometimento nutricional ou em risco nutricional associado com alguma doença catabólica;
- Crianças em dieta enteral.

4.8 Fórmula alimentar e suplemento alimentar para adolescentes, adultos e idosos

- Adolescentes, adultos e idosos com risco nutricional associado com doença catabólica, desnutrição leve/moderada associada com doença catabólica ou indivíduos com desnutrição grave.
- Adolescentes, adultos e idosos em dieta enteral.

Observação:
Incluem-se como situações de doenças catabólicas:
- Alimentação através de sonda (sonda nasogástrica - SNG, sonda nasoenteral - SNE, gastrostomia - GTT, jejunostomia);
- Desnutrição grave (com avaliação antropométrica e avaliação subjetiva global que comprovem);
- Distúrbios de absorção de nutrientes (doenças inflamatórias intestinais, cirurgias que modifiquem o trânsito intestinal e que, como consequência, impeçam a manutenção de um estado nutricional adequado);
- Doenças cardíacas (insuficiência cardíaca, Doença de Chagas);
- Doenças degenerativas (Alzheimer, Parkinson, Esclerose Múltipla, Esclerose Lateral Amiotrófica);
- Doenças infectocontagiosas que impactam diretamente o estado nutricional (HIV, tuberculose);
- Doenças hepáticas (cirrose, hepatite crônica);
- Doenças neurológicas (inconsciência, doenças neurológicas, coma, acidentes vasculares cerebrais);

- Doenças pulmonares (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC);
- Grandes queimados;
- Neoplasias associadas à quimioterapia, radioterapia e/ou cirurgia;
- Transplantes (fígado, rins, coração, pulmão).

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL

O estado nutricional adequado de um indivíduo é fundamental para a saúde e bem-estar geral. Sabidamente, ele contribui para a prevenção de doenças, manutenção da saúde, e melhoria geral da qualidade de vida.

Nesse sentido, o risco nutricional refere-se à probabilidade de um indivíduo desenvolver deficiências nutricionais que possam impactar negativamente sua saúde. Ele pode resultar de diversas condições, como ingestão inadequada de nutrientes, má absorção e doenças crônicas, sendo especialmente relevante em populações vulneráveis, como idosos, pacientes hospitalizados, crianças e pessoas com doenças crônicas.

O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma ferramenta amplamente utilizada para avaliar o estado nutricional, baseada na relação entre o peso e a altura de uma pessoa. No entanto, o IMC possui várias limitações que podem comprometer sua eficácia e precisão em algumas situações, como não distinguir a composição corporal, não levar em consideração as variações étnicas e genéticas, não considerar condições como edema, entre outros. Desta forma, associar métodos diversos na avaliação do estado nutricional é de suma importância.

A seguir, estão descritos os métodos de avaliação nutricional e pontos de corte a serem adotados para o diagnóstico nutricional de acordo com cada ciclo de vida.

5.1 Avaliação nutricional de crianças e adolescentes (0 a 19 anos e 29 dias)

A avaliação nutricional de crianças e adolescentes deve ser realizada com base em curvas de crescimento que sejam específicas às características individuais. Estas curvas devem levar em consideração fatores como o sexo (feminino/masculino), a idade gestacional ao nascer (pois existem curvas de crescimento específicas para prematuros) e condições específicas de saúde, como Síndrome de Down, acondroplasia e paralisia cerebral. Utilizar curvas de crescimento adequadas é fundamental para uma avaliação precisa, permitindo monitorar o desenvolvimento e identificar precocemente possíveis

desvios ou atrasos no crescimento, assegurando intervenções nutricionais e de saúde personalizadas e eficazes.

No Quadro 1 são apresentadas as referências a serem utilizadas para a avaliação nutricional destes grupos.

Quadro 1 – Referências para avaliação nutricional de crianças e adolescentes com distintas situações.

Situação	**Referência**
Crianças nascidas a termo	OMS, 2006
Crianças prematuras	Fenton; Kim, 2013
Crianças e adolescentes com Síndrome de Down	Bertapelli *et al.,* 2017
Crianças e adolescentes com acondroplasia	Neumeyer; Merker; Hagenäs, 2021
Crianças e adolescentes com paralisia cerebral	Brooks *et al*., 2011

A utilização de várias curvas de crescimento, como peso/idade, altura/idade e IMC/idade, na avaliação nutricional de crianças/adolescentes é de extrema importância, pois cada uma fornece informações complementares sobre o estado de saúde e desenvolvimento. A curva de peso/idade ajuda a identificar desvios no ganho de peso que podem indicar desnutrição aguda ou obesidade. A curva de altura/idade permite monitorar o crescimento linear, essencial para detectar possíveis problemas de crescimento e desenvolvimento ósseo bem como carências nutricionais crônicas. Já a curva de IMC/idade é crucial para avaliar a relação entre peso e altura, fornecendo uma visão mais precisa sobre o estado nutricional e o risco de doenças relacionadas ao peso. Juntas, essas curvas oferecem uma avaliação abrangente e detalhada, permitindo intervenções mais precisas e eficazes para promover a saúde e o desenvolvimento adequado.

Para avaliação do risco nutricional em crianças e adolescentes, será utilizado o instrumento "*Strongkids*: Triagem do risco de desnutrição", versão traduzida por Carvalho *et al.* (2013) e disposta no ANEXO 1.

5.2 Avaliação nutricional de adultos (20 anos a 59 anos e 29 dias)

Será considerado como desnutrição grave o paciente que se encontre com IMC inferior a 16kg/m^2 de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2000) e como desnutrição moderada e leve aqueles que se encontram com magreza grau II e magreza grau I, respectivamente (também de acordo com a classificação da OMS).

Quadro 2 – Classificação do Índice de Massa Corporal de acordo com Organização Mundial da Saúde (2000).

Classificação	**Índice de Massa Corporal (kg/m^2)**
Magreza grau III	< 16,0
Magreza grau II	16,0 – 16,9
Magreza grau I	17,0 – 18,4
Eutrofia	18,5 – 24,9
Sobrepeso	25,0 – 29,9
Obesidade grau I	30,0 – 34,9
Obesidade grau II	35,0 – 39,9
Obesidade grau III	≥ 40,0

Para avaliação do risco e diagnóstico nutricional (bem nutrido, moderadamente desnutrido e gravemente desnutrido) de adultos será utilizado o instrumento "Avaliação Subjetiva Global do Estado Nutricional (AGS)" (Detsky *et al.,* 1984), conforme apresentado no ANEXO 2.

5.3 Avaliação nutricional de idosos (60 anos ou mais)

O ponto de corte de avaliação do estado nutricional do idoso é diferente do adulto devido a várias mudanças fisiológicas que ocorrem com o envelhecimento. A medida que as pessoas envelhecem, há uma tendência natural de perda de massa muscular e aumento da massa de gordura, mesmo que o peso total possa não mudar significativamente. Além disso, a altura tende a diminuir com a idade devido à compressão dos discos intervertebrais e outras alterações na coluna vertebral. Portanto, as faixas de referência para o IMC de idosos são ajustadas para refletir essas mudanças e para melhor avaliar o risco de desnutrição e outras condições de saúde específicas da

idade avançada. Desta forma, para idosos serão adotados os pontos de corte de Lipschitz (1994).

Quadro 3 – Faixas de classificação do Índice de Massa Corporal para idosos de acordo com Lipschitz (1994).

Classificação	**Índice de Massa Corporal (kg/m^2)**
Baixo peso	< 22,0
Eutrofia	22,0 – 27,0
Sobrepeso	> 27,0

Uma avaliação nutricional completa para idosos deve considerar essas alterações e utilizar outras medidas complementares, como a avaliação da composição corporal, força muscular e do risco nutricional. A avaliação do risco nutricional em idosos será realizada através do instrumento "Avaliação Subjetiva Global do Estado Nutricional (AGS)" (Detsky *et al.,* 1984), conforme apresentado no ANEXO 2 e do instrumento "Miniavaliação Nutricional - versão reduzida (MNA®)" (Kaiser *et al*., 2013) disposta no ANEXO 3.

6. PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES

É imprescindível a abertura de processo administrativo junto ao Município, que deverá ser protocolado no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura, constando as cópias dos seguintes documentos:

- Crianças: certidão de nascimento da criança, registro geral (RG) e cadastro de pessoa física (CPF) dos pais ou responsável, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de endereço;
- Adolescentes, adultos e idosos: RG e CPF do paciente, RG e CPF do responsável (em caso de necessidade), CNS e comprovante de endereço.

Independentemente da idade e do diagnóstico, é necessário também protocolar, em via original, um relatório médico (conforme modelo disponibilizado no Departamento de Nutrição) de um profissional da rede pública de saúde, descrevendo o nome completo do paciente, o motivo que justifique a necessidade do uso da fórmula ou suplemento alimentar em questão com descrição da Classificação Internacional de

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como o peso atual e a altura do paciente (em caso de impossibilidade de avaliação, deverá ser justificado), o qual está apresentado no APÊNDICE 1.

Observações:

- No caso de crianças que necessitam de fórmulas de partida ou de seguimento, o relatório médico poderá ser elaborado por pediatra da rede pública de saúde ou por médico generalista das Unidades Básicas de Saúde;
- Para as fórmulas destinadas a crianças com doenças específicas, o relatório deverá necessariamente ser elaborado por pediatra da rede pública de saúde.

Após abertura do processo junto ao Protocolo Geral do Município, o mesmo será encaminhado ao Departamento de Nutrição, da Secretaria Municipal de Saúde. Nesse momento, o processo será avaliado por um nutricionista do setor, o qual irá elaborar um relatório nutricional, constando a prescrição da fórmula (nome do produto, quantidade diária, horários de utilização e tempo de concessão).

A conferência da documentação necessária será realizada pelo Setor de Protocolo Geral, sendo que em falta de algum documento, a família deverá ser comunicada para as adequações necessárias.

O processo terá validade de três meses. Para pacientes com prognósticos estáveis, sem necessidade de alteração da conduta nutricional, o processo poderá ser renovado semestralmente, mediante decisão do profissional nutricionista responsável. Caso haja necessidade de uso da fórmula ou suplemento alimentar além desse período, o mesmo deverá ser renovado mediante a apresentação de novo relatório médico junto ao Setor de Protocolo Geral.

7. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA QUANTIDADE DE FÓRMULA A SER FORNECIDA

A complementação alimentar será calculada a partir das necessidades nutricionais de cada paciente em relação aos macro e micronutrientes que estejam deficitários em sua dieta caseira. Este cálculo irá considerar o fornecimento essencial e necessário, considerando que o nutricionista irá realizar as orientações necessárias a fim

de que o paciente possa obter o máximo dos nutrientes necessários através de sua dieta caseira.

Os casos omissos neste Protocolo serão resolvidos pelo Departamento de Nutrição em conjunto com as hierarquias superiores desta Secretaria.

7.1 Menores de 06 meses

Será calculada quantidade de fórmula suficiente para atender a 100% das necessidades energéticas diárias utilizando energia por quilo de peso atual e para atender 100% da *Dietary Reference Intakes* (DRI) para cálcio, conforme recomendação do fabricante.

7.2 De 06 meses a 08 meses e 29 dias

Será calculada quantidade de fórmula suficiente para atender 100% da DRI para cálcio e para preparo de, no máximo, 600ml de fórmula/dia, conforme recomendação do fabricante.

7.3 Crianças com 09 meses ou mais

Será calculada quantidade de fórmula para preparo de, no máximo, 600ml de fórmula/dia, conforme recomendação do fabricante.

7.4 Crianças maiores de 02 anos, adolescentes, adultos e idosos

Devido aos recursos financeiros limitados e ao crescente número de pacientes atendidos, o Departamento de Nutrição da Prefeitura Municipal de Araguari, infelizmente, não consegue fornecer fórmulas e suplementos alimentares para todas as refeições de todos os pacientes. Para lidar com essa situação, a distribuição será feita de forma criteriosa, baseada na avaliação individual do nutricionista responsável. Assim, será adotado o princípio da equidade do Sistema Único de Saúde (SUS), que prioriza a alocação justa dos recursos de acordo com as necessidades específicas de cada paciente, garantindo que os casos mais críticos ou que demandam maior atenção nutricional recebam maior suporte.

Para pacientes com dieta via oral, será calculada quantidade de fórmula para atender, no máximo, 03 refeições por dia, enquanto que, para pacientes em uso de sonda NSG, NSE ou GTT, será calculada quantidade de fórmula para atender, no máximo, 02 refeições por dia. O número de refeições fornecidas dependerá da avaliação nutricional e das necessidades energéticas do paciente.

Será fornecido 100% das necessidades energéticas do paciente apenas para as situações em que o uso de alimentos ou de dietas artesanais estejam impossibilitadas por provocarem desequilíbrios metabólicos de difícil controle.

Observação:

- Além de receberem o suplemento alimentar, os pacientes que montarem o processo também poderão receber orientação nutricional individualizada e/ou plano alimentar individualizado caso seja desejado. Inclusive, mesmo aqueles que não se enquadrarem nos critérios para recebimento e tiverem seus processos arquivados, também poderão receber orientação nutricional caso seja desejado.

8 RELATÓRIO DO SERVIÇO SOCIAL

A inclusão do relatório social elaborado por assistente social tem o objetivo de fornecer uma análise detalhada e contextualizada da situação socioeconômica do paciente e de sua família, permitindo que os profissionais do Departamento de Nutrição tomem decisões informadas e justas. Nos APÊNDICES 2 e 3 encontram-se instrumentos que poderão ser utilizados pelo profissional no momento da visita domiciliar.

A equidade é um pilar essencial do SUS e deve ser aplicada na disponibilização de fórmulas alimentares. Este princípio visa reduzir desigualdades, proporcionando recursos adicionais e suporte para aqueles que enfrentam maiores desafios para alcançar um bom estado de saúde.

Ao direcionar mais recursos para aqueles que mais necessitam, o SUS pode utilizar seus recursos de maneira mais eficiente. Isso evita desperdícios e garante que as intervenções tenham o máximo de impacto possível.

Nesse sentido, ao fazer a visita domiciliar ao paciente, o assistente social irá avaliar as condições socioeconômicas e de saúde do paciente, de forma a acordar se a

há a possibilidade de uma contrapartida da família e apurar a quantidade a ser adquirida pela mesma.

A visita do assistente social ocorrerá para os pacientes requerentes de fórmulas infantis de partida ou para fórmulas especializadas para tratamento de alergias que apresentam alto custo. Além disso, os profissionais nutricionistas também podem solicitar a visita do assistente social a qualquer momento, inclusive em casos que não se enquadrem nos critérios supracitados.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Projeto Diretrizes, 2006.

BERTAPELLI, F.; AGIOVLASITIS, S.; MACHADO, M. R.; DO VAL ROSO, R.; GUERRA-JUNIOR, G. Growth charts for Brazilian children with Down syndrome: Birth to 20 years of age. **J Epidemiol**., v. 27, n. 6, p. 265-273, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. **Aleitamento materno, distribuição de fórmulas infantil em estabelecimentos de saúde e a legislação**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 28p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de Saúde**: Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional-SISVAN. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Política de Saúde. Saúde da Mulher. **Gestação de alto risco: manual técnico**. 3a ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2000.

BROOKS, J.; DAY, S.; SHAVELLE, R.; STRAUSS, D. Low weight, morbidity, and mortality in children with cerebral palsy: new clinical growth charts. **Pediatrics**, v. 128, p. 299-307, 2011.

CÓDIGO DE ÉTICA DO ASSISTENTE SOCIAL – Resolução do CFESS de 13 de março de 1993.

CÓDIGO DE ÉTICA DOS NUTRICIONISTAS - Resolução do CFN nº 334 de 10 de maio de 2004.

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA - Resolução do CFM nº 1.246 de 08 de janeiro de 1988.

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Resolução nº 39 de 09 de dezembro de 2010.

DETSKY, A. S.; BAKER, J. P.; MENDELSON, R. A.; WOLMAN, S. L.; WESSON, D. E.; JEEJEEBHOY, K. N. Evaluating the accuracy of nutritional assessment techniques applied to hospitalized patients: methodology and comparisons. **JPEN J Parenter Enteral Nutr**, v. 8, p. 153-9, 1984.

Famílias em situação de vulnerabilidade ou risco psicossocial – Ana Cristina Belizia Schlithler/Mariane Ceron/ Daniel Almeida Gonçalves – Especialização em Saúde da Família – Modulo Psicossocial – UNA-SUS/UNIFESP.

FENTON, T. R.; KIM, J. H. A systematic review and metaanalysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. **BMC Pediatr**., v. 13, p. 59, 2013.
KAISER, M. J.; *et al.* Validation of the Mini Nutritional Assessment Short-Form (MNA®-SF): A practical tool for identification of nutritional status. **J Nutr Health Aging**, v. 13, p. 782-788, 2009.

KOLETZKO, S. *et al*. Diagnostic Approach and Management of Cow's-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. **JPGN**, v. 55, n. 2, 2012. p. 221-229.

LEI ORGÂNICA DA SAÚDE – Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.
LEI ORGÂNICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (LOSAN) - Lei n° 11.346 de 15 de setembro de 2006.

LIPSCHITZ, D. A. Screening for nutritional status in the elderly. **Primary Care**, v. 21, n. 1, p. 55-67, 1994.

NEUMEYER, L.; MERKER, A.; HAGENÄS, L. Clinical charts for surveillance of growth and body proportion development in achondroplasia and examples of their use. **Am J Med Genet A**., v. 185, n. 2, p. 401-412, 2021.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Child Growth Standards. Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age. Methods and development. 2006. 336p.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. CID-10. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde.

POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN) - Portaria nº 2.715 de 17 de novembro de 2011.

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (PNSAN) – Decreto nº 7.272 de 25 de agosto de 2010.

Protocolo clínico para normatização da dispensação de fórmulas infantis especiais a pacientes com alergia à proteína do leite de vaca atendidos pelo Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo – Diário oficial – Poder executivo – Seção I – pag. 42, São Paulo, 117 (223), 2007.

WORLD HELTH ORGANIZATION (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. (Technical report, 894). Geneva, 2000.

Araguari, 01 de janeiro de 2025

Ana Beatriz Carrijo Rodrigues
CRN9 17686

Caroline Moema de Carvalho Romão Oliveira
CRN9 9122

Claudia Maria Martins de Sousa
CRN9 12990

Fabianne Ferreira Guimarães Barbosa de Sousa
CRN9 28605

Laura Cristina Tibiletti Balieiro
CRN9 15243

Linander de Lima Campos
CRN9 16047

Luana Thomazetto Rossato
CRN9 16181

Luciana Gomes Peixoto
CRN9 18469

Maria Fernanda C. Rezende
CRN9 1602

Marlice Maldonado
CRN9 0294

Patrícia Tatiana Veronez
CRN9 8620

Thamara Antunes Fernandes
CRN9 31758P

APÊNDICES

APÊNDICE 1 – RELATÓRIO MÉDICO

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL

LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR

SOLICITAÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR

Campos de preenchimento exclusivo pelo médico solicitante

Nome completo do paciente*:

Nome da mãe do paciente*:

Data de nascimento do paciente*:

Endereço do paciente* (rua, nº, bairro):

Dados antropométricos:

Peso atual do paciente (kg)*:		
Paciente perdeu peso nos últimos 06 meses*:	( )NÃO	( )SIM. Quanto?_____
Comprimento/Altura do paciente (cm/m)*:		
Paciente restrito ao leito*:	( )NÃO ( )SIM	

Obs.: na impossibilidade de aferição de peso e estatura, justificar*:

_____

CID-10/Diagnóstico*:

Medicamentos em uso*:

1	
2	
3	
4	
5	

Atestado de capacidade*: *A solicitação do suplemento alimentar deverá ser realizada pelo paciente. Entretanto, fica dispensada a obrigatoriedade da presença física do paciente considerado incapaz de acordo com os 3° e 4° do Código Civil.*

O paciente é considerado incapaz? ( ) NÃO ( ) SIM.

Indicar o nome do responsável pelo paciente, o qual poderá realizar a solicitação do suplemento alimentar.

Responsável 1/ Grau de parentesco:

Responsável 2/ Grau de parentesco:

Nome do médico solicitante*:

Data da solicitação*: ___/____/_____

_____

Assinatura e carimbo do médico:

Campos preenchidos pelo paciente ou responsável:

Telefone para contato*: (___) _____-_____

Endereço atual do paciente*:

*Campos de preenchimento obrigatório

APÊNDICE 2 - RELATÓRIO DO SERVIÇO SOCIAL - FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES

1. Número do Processo:
2. Unidade de Saúde de Referência:
3. Identificação do Beneficiário
3.1 Nome do Beneficiado:
3.2 Data de Nascimento: / / 3.3 Sexo: F ( ) M ( )
3.4. RG ou CPF: 3.5 CNS:
3.6 Endereço:
3.7 Telefone:
4. Identificação do Responsável
4.1 Nome:
4.2 RG ou CPF:
4.3 Grau de Parentesco: 4.4 Fone:
5. Características da Família
5.1 Quantas famílias residem neste domicílio? 5.2 Quantas pessoas residem no domicilio?
5.3 Há pessoas analfabetas?
5.4 A família está inscrita no CadÚnico?
5.5. A família participa de programas sociais e/ou recebe algum benefício? Quais?
( ) Bolsa Família ( ) BPC ( ) Programa Habitacional
( ) Outro
5.6 Há pessoas desempregadas: ( ) sim ( ) não Quantos?
5.7 Gastos com alimentação:
5.8 Gastos com medicamentos:
5.9. Outros gastos (especificar):
6. Renda Familiar:
7. Características do Domicilio
7.1 Residência: ( ) própria ( ) alugada ( ) cedida ( ) área de invasão
7.2 Construção: ( ) alvenaria ( ) madeira ( ) mista ( ) outro
7.3 Número de cômodos:
7.4 A residência possui energia: ( )sim ( ) não
7.5 Abastecimento de água: ( ) encanada e tratada ( ) de poço ( ) outro
7.6 O lixo é coletado: sim ( ) não( )
8. Situação Saúde:
8.1 Suplemento Alimentar:
8.2 Previsão do período de uso:
8.3 Histórico:
9. Parecer Social:

10. Data da entrevista: / /
11. Assinatura do Entrevistado:

12 – Composição Familiar:
Número do Processo:_____

	Nome	Idade	Parentesco	Escolaridade	Ocupação	Situação Empregatícia	Renda
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

***Situação Empregatícia**
1 – Empregado com vínculo empregatício
2 – Empregado sem vínculo empregatício
3 – Autônomo
4 – Desempregado
5 – Aposentado/ Pensionista

Observações:

APÊNDICE 3 - ESCALA DE RISCO FAMILIAR

	Dados da Ficha A (Sentinelas de Risco)	**Definições das Sentinelas de Risco**	**Escore de Risco**
A	Acamado	Toda pessoa restrita ao seu domicílio, por falta de habilidade e/ou incapacidade de locomoção por si só a qualquer unidade de saúde.	**3**
B	Deficiência Física	Defeito ou condição física de longa duração ou permanente que dificulta ou impede a realização de determinadas atividades cotidianas, escolares, de trabalho ou de lazer.	**3**
C	Deficiência Mental	Defeito ou condição mental de longa duração ou permanente que dificulta ou impede a realização de determinadas atividades cotidianas, escolares, de trabalho ou de lazer.	**3**
C	Baixas Condições de Saneamento	Saneamento implica no controle dos fatores do meio físico do homem que podem exercer efeitos prejudiciais à sua saúde.	**3**
E	Desnutrição (Grave)	Percentil menor que 0,1 e peso muito baixo para a idade.	**3**
F	Alergia a proteína do leite (APLV) e outros alimentos	Alergia a proteína do leite e outros alimentos.	**3**
G	APLV	Reação do sistema do sistema imunológico às proteínas do leite.	**2**
H	Intolerância à lactose	Dificuldade do organismo em digerir a lactose do leite, devido à diminuição ou ausência de lactase, enzima que digere.	**2**
I	Drogadição	Utilização compulsiva de drogas lícitas ou ilícitas que apresentem potencial para causar dependência química (álcool, tabaco, benzodiazepínicos, barbitúricos, e drogas ilícitas).	**2**
J	Desemprego	Situação na qual a pessoa não esteja exercendo nenhuma ocupação (não incluir na avaliação férias, licenças ou afastamentos temporários). A realização de tarefas domésticas é considerada ocupação (trabalho doméstico), mesmo que não seja remunerado.	**2**
K	Responsável pelo sustento e subsistência familiar doente	Pessoa que é mantenedora das despesas familiares e encontra-se com alguma doença em fase de tratamento e incapacitado no momento para o trabalho.	**2**

L	Criança sem a paternidade reconhecida	Criança que não consta no Registro Civil o nome do pai.	**2**
M	Mulher arrimo de família	Mulher que sustenta a família, muitas vezes sendo a única que trabalha.	**1**
N	Analfabetismo	Pessoa que, a partir da idade escolar, não sabe ler nem escrever no mínimo um bilhete, e/ou que sabe apenas assinar o nome.	**1**
O	Menor de 06 meses	Lactente com idade até 5 meses e 29 dias.	**1**
P	Hipertensão arterial sistólica	Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140mmHg e pressão arterial diastólica maior ou igual a 90mmHg, em indivíduos que não usam medicação anti-hipertensiva.	**1**
Q	Diabetes *mellitus*	Grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos.	**1**
R	Relação Morador/Cômodo	Número de cômodos na residência dividido pelo número de moradores do domicílio. São considerados cômodos todos os compartimentos integrantes do domicílio, inclusive banheiro e cozinha, separados por paredes, e os existentes na parte externa do prédio, desde que constituam parte integrante do domicílio, com exceção de corredores, alpendres, varandas abertas, garagens, depósitos.	> que 1 3 Igual a 1 - 2 < que 1 - 1
S	Relação nº de dependentes menores	Número de filhos por família ou dependentes – Guarda ou Tutela.	Até 2 (pontuar 1) Até 3 (pontuar 2) > de 3 (pontuar 3)

Cálculo do risco familiar

Escore Total	Risco Familiar
5 ou 6	R1 – Risco menor
7 ou 8	R2 – Risco médio
Acima de 9	R3 – Risco máximo

ANEXOS

ANEXO 1 - TRIAGEM DE RISCO NUTRICIONAL EM PEDIATRIA (STRONGKIDS)

Parte 1. Perguntas a serem respondidas pelo profissional de saúde	**Pontos**
Existe alguma doença de base que pode causar desnutrição ou cirurgia de grande porte prevista?	Sim: 2 Não: 0
O paciente apresenta estado nutricional prejudicado de acordo com a avaliação clínica subjetiva? ( ) Massa muscular reduzida( ) Gordura subcutânea reduzida ( ) Face emagrecida ( ) Outros sinais - Especificar: _____	Sim: 1 Não: 0
Parte 2. Perguntas a serem questionadas ao cuidador da criança	
Ingestão alimentar e perdas - apresenta alguns dos itens abaixo? ( ) Diarreia (>5 vezes por dia) e/ou vômito (>3 vezes por dia) excessivos nos últimos dias? ( ) Diminuição da ingestão alimentar durante os últimos dias antes da internação (não incluindo jejum para procedimento ou cirurgia eletivos)? ( ) Recomendação de intervenção nutricional preexistente? Se sim, qual? _____ ( ) Incapacidade de ingestão alimentar adequada por causa de dor?	Sim: 1 Não: 0
Perda de peso ou pouco ganho de peso - houve perda de peso ou nenhum ganho de peso (em crianças <1 ano) durante as últimas semanas/os últimos meses?	Sim: 1 Não: 0
Pontuação total	

Classificação	**Conduta**
( ) 0 pontos - baixo risco	Nenhuma intervenção nutricional é necessária no momento; checar o peso regularmente e reavaliar o risco nutricional semanalmente. Data próxima triagem:___/_____/_____
( ) 1 a 3 pontos - médio risco	Consultar médico e nutricionista para diagnóstico nutricional completo; considerar intervenção nutricional; checar o peso das duas vezes por semana e reavaliar risco nutricional após uma semana. Data avaliação nutricional: _____/_____/_____
( ) 4 a 5 pontos - alto risco	Consultar médico e nutricionista para diagnóstico nutricional completo; orientação nutricional individualizada e acompanhamento; avaliar prescrição de suplemento oral. Data avaliação nutricional: _____/_____/_____

*Situações de risco nutricional: ( ) Anorexia nervosa; ( ) Doença infecciosa (ex: AIDS); ( ) Doença renal crônica; ( ) Câncer; ( ) Baixo peso para idade/prematuridade (usar idade corrigida até 6o mês); ( ) Síndrome do intestino curto; ( ) Doença cardíaca crônica; ( ) Doença metabólica; ( ) Fibrose cística; ( ) Queimaduras; ( ) Doença inflamatória intestinal; ( ) Doença celíaca; ( ) Doença muscular; ( ) Pancreatite; ( ) Trauma; ( ) Doença hepática crônica; ( ) Displasia broncopulmonar (até 2 anos); ( ) Deficiência mental/paralisia cerebral; ( ) Cirurgia de grande porte (pré ou pós operatório); ( ) Não específico - classificado pelo profissional
(Detalhar: _____)

Informações adicionais de interesse nutricional:

Responsável pela triagem (assinatura e carimbo)

ANEXO 2 - AVALIAÇÃO SUBJETIVA GLOBAL DO ESTADO NUTRICIONAL (AGS)

A – História

1. Alteração no peso
Perda total nos últimos 6 meses: total =_____kg; % perda =_____
Alteração nas últimas duas semanas: ( ) Aumento ( ) Sem alteração ( ) Diminuição

2. Alteração na ingestão alimentar
( ) Sem alteração
( ) Alterada:
Duração = _____
Tipo: ( ) Dieta sólida subótima ( ) Dieta líquida completa ( ) Líquidos hipocalóricos ( ) Inanição

3. Sintomas gastrintestinais (que persistam por > 2 semanas)
( ) Nenhum ( ) Náusea ( ) Vômitos ( ) Diarreia ( ) Anorexia

4. Capacidade funcional
( ) Sem disfunção (capacidade completa)
( ) Disfunção:
Duração = _____ semanas.
Tipo: ( ) Trabalho subótimo ( ) Ambulatório ( ) Acamado

5. Doença e sua relação com necessidades nutricionais
Diagnóstico primário (especificar):
Demanda metabólica (estresse): ( ) Sem estresse ( ) Baixo estresse ( ) Estresse moderado ( ) Estresse elevado

B - Exame físico (para cada categoria, especificar: 0 = normal, 1+ = leve, 2+ = moderada, 3+ = grave).

_____ perda de gordura subcutânea (tríceps, tórax)
_____ perda muscular (quadríceps, deltoide)
_____ edema sacral
_____ ascite
_____ edema tornozelo

C - Avaliação subjetiva global (selecione uma)

( ) A = bem nutrido ( ) B = moderadamente (ou suspeita de ser) desnutrido
( ) C = gravemente desnutrido

ANEXO 3 - MINIAVALIAÇÃO NUTRICIONAL - VERSÃO REDUZIDA (MNA®)

A - Nos últimos 3 meses houve diminuição da ingesta alimentar devido a perda de apetite, problemas digestivos ou dificuldade para mastigar ou deglutir?
0 = diminuição grave da ingesta
1 = diminuição moderada da ingesta
2 = sem diminuição da ingesta

B - Perda de peso nos últimos 3 meses
0 = superior a três quilos
1 = não sabe informar
2 = entre 1 e 3 quilos
3 = sem perda de peso

C - Mobilidade
0 = restrito ao leito ou à cadeira de rodas
1 = deambula, mas não é capaz de sair de casa
2 = normal

D - Passou por algum stress psicológico ou doença aguda nos últimos 3 meses?
0 = sim 2 = não

E - Problemas neuropsicológicos
0 = demência ou depressão grave
1 = demência ligeira
2 = sem problemas psicológicos

F1 - Índice de Massa Corporal (IMC = peso [kg]/estatura [m^2])
0 = IMC < 19
1 = 19 ≤ IMC < 21
2 = 21 ≤ IMC < 23
3 = IMC ≥ 23

SE O CÁLCULO DO IMC NÃO FOR POSSÍVEL, SUBSTITUIR A QUESTÃO F1 PELA F2.
NÃO PREENCHA A QUESTÃO F2 SE A QUESTÃO F1 JÁ TIVER SIDO COMPLETADA.

F2 - Circunferência da Panturrilha (CP) em centímetros
0 = CP menor que 31 3 = CP maior ou igual a 31

Pontuação da Triagem (subtotal, máximo de 14 pontos)
12 - 14 pontos: estado nutricional normal
8 - 11 pontos: sob risco de desnutrição
0 - 7 pontos: desnutrido